

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

LUÍSA REBECHI ZAMPIERI

**ESTILOS PARENTAIS DE ALIMENTAÇÃO E DIFICULDADES ALIMENTARES
PEDIÁTRICAS NO CONTEXTO DA HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL**

Porto Alegre

2026

LUÍSA REBECHI ZAMPIERI

**ESTILOS PARENTAIS DE ALIMENTAÇÃO E DIFICULDADES ALIMENTARES
PEDIÁTRICAS NO CONTEXTO DA HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL**

Dissertação apresentada para o Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Vera Lúcia Bosa

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Zampieri, Luísa Rebechi
ESTILOS PARENTAIS DE ALIMENTAÇÃO E DIFICULDADES
ALIMENTARES PEDIÁTRICAS NO CONTEXTO DA HOSPITALIZAÇÃO
INFANTIL / Luísa Rebechi Zampieri. -- 2026.
105 f.
Orientadora: Vera Lúcia Bosa.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. Transtornos da Alimentação e da Ingestão de
Alimentos. 2. Criança Hospitalizada. 3. Relação
Parental. I. Lúcia Bosa, Vera, orient. II. Título.

LUÍSA REBECHI ZAMPIERI

ESTILOS PARENTAIS DE ALIMENTAÇÃO E DIFICULDADES ALIMENTARES
PEDIÁTRICAS NO CONTEXTO DA HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

APROVADA em 25/02/26

BANCA EXAMINADORA

Prof^a Dr^a Erissandra Gomes
UFRGS

Prof^a Dr^a Juliana Rombaldi Bernardi
UFRGS

Prof^a Dr^a Lisiane da Rosa Barbosa
UFSCPA

*Às crianças e famílias que, com sua coragem e resiliência, inspiraram a construção
deste trabalho.*

AGRADECIMENTOS

A construção desta dissertação representa muito mais do que a conclusão de uma etapa acadêmica, simboliza uma trajetória de aprendizados, desafios, crescimento e, principalmente, de encontros com pessoas que tornaram este caminho possível e significativo.

À minha orientadora, Profe Vera, minha profunda gratidão pela confiança, acolhimento e generosidade ao compartilhar conhecimentos e experiências. Sua orientação foi essencial não apenas para o desenvolvimento deste trabalho, mas também para minha formação profissional e pessoal.

À Haíssa, meu sincero e caloroso agradecimento por ter sido a idealizadora deste projeto e por ter me acompanhado e auxiliado em cada etapa dessa trajetória. Obrigada pela parceria, disponibilidade, generosidade em compartilhar conhecimentos e pelo apoio constante durante o desenvolvimento deste trabalho. Sua contribuição foi essencial para que este estudo se tornasse possível.

Aos professores que participaram da banca examinadora, agradeço pela disponibilidade, pelo olhar atento e pelas contribuições que enriquecem esta pesquisa e fortalecem minha trajetória científica.

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul por proporcionar um ambiente de formação científica, crítica e humana, oferecendo oportunidades que contribuíram de forma decisiva para minha trajetória acadêmica e profissional desde a graduação.

Ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre onde esta pesquisa foi realizada, minha sincera gratidão por permitir e apoiar a coleta de dados, pelo acolhimento e pela colaboração dos profissionais que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste estudo.

Aos alunos bolsistas e voluntários e residentes, meu agradecimento pela dedicação, parceria e colaboração durante a condução da pesquisa. O comprometimento, o cuidado na coleta de dados e o trabalho em equipe foram fundamentais para a concretização deste estudo.

Aos cuidadores e às crianças participantes, deixo um agradecimento especial e cheio de respeito. Mesmo em momentos delicados, compartilharam suas vivências e permitiram que este estudo fosse realizado. Este trabalho existe por vocês e para vocês.

Às colegas e amigas que caminharam ao meu lado durante essa jornada, obrigada pelas trocas, pela escuta e por tornarem o percurso mais significativo e enriquecedor.

Ao Rafael, meu parceiro de vida, meu sincero agradecimento. Obrigada pelo amor, pelo incentivo, pela compreensão e pelo acolhimento constantes, especialmente por vivenciar comigo, dia após dia, as dores e as delícias da vida acadêmica. Sua presença tornou essa caminhada mais leve, sendo fundamental para que eu seguisse firme mesmo nos momentos mais desafiadores.

À minha família, em especial aos meus pais, Aline e Claudio, meu agradecimento mais profundo. Obrigada pelo amor, pelo apoio incondicional e por serem meu porto seguro em todos os momentos. Cada conquista minha também é de vocês. Agradeço, especialmente, pelo incentivo constante e pela valorização da educação como um pilar fundamental para a minha vida, ensinamento que sempre guiou minhas escolhas e tornou possível a construção deste caminho acadêmico e profissional.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, fizeram parte desta caminhada e contribuíram para que este sonho se tornasse realidade. Levo comigo cada aprendizado e cada gesto de carinho recebido ao longo dessa trajetória.

Com carinho e gratidão.

RESUMO

Introdução: A hospitalização pediátrica pode impactar o comportamento alimentar infantil e a dinâmica alimentar familiar pois representa um evento potencialmente estressor, associado a alterações na rotina, exposição a procedimentos invasivos e impacto emocional para crianças e seus cuidadores. Nesse contexto, as dificuldades alimentares pediátricas (DAPs) constituem uma condição frequente, com potencial impacto no estado nutricional, no crescimento e no desenvolvimento infantil. Os estilos parentais de alimentação emergem, nesse sentido, como um elemento central para a compreensão das práticas alimentares e das respostas da criança frente à alimentação. Eles influenciam o desenvolvimento dos comportamentos alimentares, contudo, a relação entre essas práticas e as DAPs ainda é pouco explorada no cenário da hospitalização pediátrica. O objetivo do estudo foi analisar os estilos parentais de alimentação e sua associação com DAPs em crianças hospitalizadas.

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado com crianças de seis meses a 14 anos incompletos hospitalizadas na unidade de internação pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e seus cuidadores primários. Foram excluídas crianças em uso exclusivo de via alimentar alternativa ou com ingestão oral apenas para estímulo. Os dados foram coletados por meio de prontuário eletrônico das crianças e entrevistas estruturadas para os cuidadores. Os estilos parentais de alimentação foram avaliados pelo Questionário de Estilos Parentais na Alimentação (QEPA), considerando tanto os pontos de corte propostos no estudo original quanto a média da própria amostra para a classificação das dimensões de exigência e responsividade. As DAPs foram identificadas por meio da Escala Brasileira de Alimentação Infantil (EBAI) e do critério funcional do *American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System* (ASHA-NOMS). Os dados foram analisados por estatística descritiva e testes qui-quadrado de Pearson e análise de variância, adotando-se nível de significância de 5%. **Resultados:** Foram analisadas 337 pares de cuidador-criança. Observou-se predominância do sexo masculino entre as crianças (56,7%), com mediana de idade de 4 anos (2-7). 73,3% delas apresentavam hospitalizações prévias e 52,5% foram classificadas com Condições Crônicas Complexas (CCC). Entre os cuidadores, 88,1% eram do sexo feminino e 43,9% apresentavam insegurança alimentar. As DAPs estavam presentes em 25,5% das crianças. A utilização de diferentes pontos de corte resultou em variações na distribuição dos estilos parentais, com frequência de alta responsividade de 85,2% pelo ponto de corte original e 52,5% pela média da amostra ($p < 0,001$), enquanto a alta exigência variou de 30% para 46% ($p < 0,001$). O estilo indulgente foi o mais frequente, variando de 37,1% para 61,4% conforme o critério adotado. Verificou-se associação entre maior exigência

parental e presença de DAPs ($p=0,018$), percepção de DAPs ($p=0,004$), dificuldades na aceitação alimentar e resistência a novos alimentos ($p<0,001$), além de problemas na progressão de texturas ($p=0,020$). A menor responsividade associou-se à percepção de DAPs ($p=0,013$), dificuldades na aceitação alimentar ($p=0,015$) e resistência a novos alimentos ($p=0,017$). **Conclusão:** Os estilos parentais de alimentação estão associados às DAPs em crianças hospitalizadas, destacando-se o papel da maior exigência e menor responsividade como fatores relacionados a piores desfechos alimentares. Além disso, a escolha dos pontos de corte influencia significativamente a classificação dos estilos parentais.

Palavras-chave: Transtornos da Alimentação e da Ingestão de Alimentos; Criança Hospitalizada; Relação Parental.

ABSTRACT

Introduction: Pediatric hospitalization may impact children's eating behavior and family feeding dynamics, as it represents a potentially stressful event associated with changes in routine, exposure to invasive procedures, and emotional burden for children and their caregivers. In this context, Pediatric Feeding Disorder (PFD) is a frequent condition with potential consequences for nutritional status, growth, and child development. Feeding parenting styles emerge as a central element for understanding feeding practices and children's responses to food. These styles influence the development of eating behaviors; however, the relationship between these practices and PFD remains underexplored in the pediatric hospitalization setting. The purpose of study is to analyze feeding parenting styles and their association with PFD in hospitalized children. **Methods:** This was a cross-sectional study conducted with children aged six months to under 14 years hospitalized in the pediatric inpatient unit of Hospital de Clínicas de Porto Alegre and their primary caregivers. Children exclusively receiving alternative feeding routes or with oral intake only for stimulation were excluded. Data were collected from children's electronic medical records and structured caregiver interviews. Feeding parenting styles were assessed using the Caregiver's Feeding Styles Questionnaire (CFSQ), considering both the cut-off points proposed in the original study and the sample mean to classify the dimensions of demandingness and responsiveness. PFD was identified using the Montreal Children's Hospital Feeding Scale (MCH-FS) and the functional criteria of the American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System (ASHA-NOMS). Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson's chi-square tests, and analysis of variance, adopting a significance level of 5%. **Results:** A total of 337 caregiver-child dyads were analyzed. Most children were male (56.7%), with a median age of 4 years (IQR 2–7). Previous hospitalizations were reported in 73.3% of cases, and 52.5% of children were classified as having Complex Chronic Conditions (CCC). Among caregivers, 88.1% were female, and 43.9% experienced food insecurity. PFD was identified in 25.5% of children. The use of different cut-off points resulted in variations in the distribution of feeding parenting styles, with high responsiveness observed in 85.2% using the original cut-off and 52.5% using the sample mean ($p<0.001$), while high demandingness ranged from 30% to 46% ($p<0.001$). The indulgent style was the most frequent, ranging from 37.1% to 61.4% depending on the adopted criterion. Higher parental demandingness was associated with the presence of PFD ($p=0.018$), caregiver perception of PFD ($p=0.004$), feeding acceptance difficulties and resistance to new foods ($p<0.001$), and problems with texture progression ($p=0.020$). Lower responsiveness was

associated with caregiver perception of PFD ($p=0.013$), feeding acceptance difficulties ($p=0.015$), and resistance to new foods ($p=0.017$). **Conclusion:** Feeding parenting styles are associated with PFD in hospitalized children, highlighting the role of higher demandingness and lower responsiveness as factors related to poorer feeding outcomes. Additionally, the choice of cut-off points significantly influences the classification of feeding parenting styles.

Keywords: Feeding and Eating Disorders of Childhood; Child, Hospitalized.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ANOVA	Análise de Variância
ASHA-NOMS	<i>American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System</i>
BPC	Benefício de Prestação Continuada
CCC	Condição Crônica Complexa
CFSQ	<i>Caregiver's Feeding Styles Questionnaire</i>
DAP	Dificuldade Alimentar Pediátrica
EBAI	Escala Brasileira de Alimentação Infantil
EBIA	Escala Brasileira de Insegurança Alimentar
E/I	Estatura para Idade
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
IMC	Índice de Massa Corporal
IMC/I	Índice de Massa Corporal para Idade
LGPD	Lei de Proteção de Dados
MCH-FS	<i>Montreal Children's Hospital Feeding Scale</i>
OMS	Organização Mundial da Saúde
PC	Paralisia Cerebral
P/E	Peso para Estatura
QEPA	Questionário de Estilos Parentais na Alimentação
REDCap	<i>Research Electronic Data Capture</i>
SPSS	<i>Statistical Package for Social Science</i>
TALE	Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
WHO	World Health Organization

LISTA DE ILUSTRAÇÕES E QUADROS

Quadro 1	Critérios diagnósticos para Dificuldade Alimentar Pediátrica.....	21
Figura 1	Estilos parentais segundo Baumrind e posteriormente modificados por Maccoby e Martin	25
Figura 2	Dimensões do estilo parental.....	26
Figura 3	Logística da coleta de dados	32
Figura 4	Fluxograma da classificação das Dificuldades Alimentares Pediátricas	38

FIGURAS DO ARTIGO 1

Figura 1	Média de resposta por item do Questionário de Estilos Parentais de Alimentação (QEPA) de cuidadores de crianças hospitalizadas.....	48
Figura 2	Classificação tipológica dos estilos parentais de alimentação de cuidadores de crianças hospitalizadas.....	49

LISTA DE TABELAS

TABELAS DO ARTIGO 1

Tabela 1	Caracterização clínica e nutricional das crianças e sociodemográfica dos cuidadores de crianças hospitalizadas	46
Tabela 2	Pontos de corte para classificação dos estilos parentais de cuidadores de crianças hospitalizadas	49
Tabela 3	Associação entre características sociodemográficas de cuidadores, clínicas e nutricionais de crianças hospitalizadas e a dimensão de responsividade segundo diferentes pontos de corte	51
Tabela 4	Associação entre características sociodemográficas de cuidadores, clínicas e nutricionais de crianças hospitalizadas e a dimensão de exigência segundo diferentes pontos de corte	53

TABELAS DO ARTIGO 2

Tabela 1	Caracterização clínica e nutricional das crianças hospitalizadas e sociodemográfica dos cuidadores	70
Tabela 2	Associação entre características sociodemográficas dos cuidadores e clínicas e nutricionais das crianças hospitalizadas com as dimensões de exigência e responsividade	72
Tabela 3	Associação entre os níveis de exigência e responsividade parentais e Dificuldades Alimentares Pediátricas em crianças hospitalizadas.....	74

SUMÁRIO

1	OBJETO DE ESTUDO	15
1.1	Tema do estudo	15
1.2	Delineamento do estudo	15
1.3	Problema de pesquisa	15
2	INTRODUÇÃO	16
3	REFERENCIAL TEÓRICO	18
3.1	Cuidado do paciente pediátrico hospitalizado	18
3.2	Dificuldades alimentares pediátricas	20
3.3	Comportamento alimentar infantil	23
3.4	Estilo parental de alimentação	24
4	JUSTIFICATIVA	28
5	HIPÓTESE DE PESQUISA	29
6	OBJETIVOS	30
6.1	Objetivo geral	30
6.2	Objetivos específicos	30
7	MÉTODOS	31
7.1	Delineamento e população do estudo	31
7.2	Cálculo amostral	31
7.3	Crítérios de inclusão e de exclusão	31
7.4	Coletas de dados	32
7.5	Variáveis em estudo.....	33
7.6	Processamento e análise dos dados.....	38
7.7	Aspectos éticos	39
8	RESULTADOS.....	40
8.1	Artigo 1	40
8.2	Artigo 2	62
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	84

REFERÊNCIAS	86
APÊNDICES	92
APÊNDICE A - Questionário dos dados sócio-demográficos e clínicos	92
APÊNDICE B - TCLE para crianças menores de seis anos	97
APÊNDICE C - TALE para crianças maiores de seis anos	98
APÊNDICE D - TCLE para cuidadores	100
ANEXOS	101
ANEXO 1 - Questionário de Estilos Parentais de Alimentação	101
ANEXO 2 - Escala Brasileira de Alimentação Infantil	103
ANEXO 3 - <i>American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System (ASHA-NOMS)</i>	104

1 OBJETO DE PESQUISA

1.1 Tema: Estilos parentais na alimentação e Dificuldades Alimentares Pediátricas

1.2 Delineamento do tema: Associação entre os estilos parentais de alimentação e as Dificuldades Alimentares Pediátricas.

1.3 Problemas de pesquisa:

- Os estilos parentais estão associados às Dificuldades Alimentares Pediátricas em crianças hospitalizadas?

2 INTRODUÇÃO

A hospitalização infantil configura-se como um evento potencialmente estressor, capaz de provocar alterações significativas na dinâmica criança–família. O afastamento do convívio social habitual, a exposição a procedimentos invasivos, a vivência de dor e sofrimento, bem como a necessidade de adaptação a uma nova rotina, impõem desafios emocionais e psicossociais à criança e aos seus cuidadores (SANTOS et al., 2016). Nesse contexto, a alimentação frequentemente sofre modificações, tornando-se um dos principais focos de preocupação familiar, uma vez que passa a ser percebida como um indicador do estado de saúde e da recuperação clínica da criança (OLIVEIRA et al., 2015; BEZERRA et al., 2021).

Essas mudanças no ambiente e na rotina alimentar podem favorecer o surgimento ou o agravamento das Dificuldades Alimentares Pediátricas (DAPs). As DAPs caracterizam-se por ingestão oral prejudicada ou inadequada para a idade, associada a disfunções médicas, nutricionais, de habilidades alimentares e/ou psicossociais, configurando-se como uma condição de natureza multifatorial e interativa (GODAY et al., 2019). Suas manifestações incluem recusa alimentar, seletividade, dificuldades de mastigação e deglutição, além de comportamentos desadaptativos durante as refeições, com repercussões que extrapolam o âmbito alimentar e impactam o crescimento, o estado nutricional, o desenvolvimento cognitivo e a dinâmica familiar (KERZNER et al., 2015; GODAY et al., 2019).

No contexto da hospitalização pediátrica, tais repercussões tendem a ser intensificadas. A presença de sintomas clínicos, o uso de medicações, as restrições impostas pelo ambiente hospitalar e o estresse emocional podem comprometer a aceitação alimentar e a autorregulação da ingestão. Assim, as DAPs não devem ser compreendidas apenas como consequência de fatores orgânicos, mas também como resultado da interação entre a criança, o ambiente e os cuidadores, reforçando a necessidade de uma abordagem ampliada e interdisciplinar (GODAY et al., 2019).

A compreensão das DAPs exige, portanto, a análise do comportamento alimentar infantil. Nesse processo, a família destaca-se como o principal agente de socialização alimentar. As interações estabelecidas entre cuidadores e crianças durante as refeições, bem como as crenças, expectativas e práticas parentais, exercem influência direta sobre a aceitação alimentar, o desenvolvimento da autorregulação e a construção das preferências alimentares infantis (VENTURA; BIRCH, 2008; SCAGLIONI et al., 2008). Em situações de adoecimento e hospitalização, essas interações podem ser modificadas, com repercussões importantes sobre o comportamento alimentar da criança.

Os estilos parentais de alimentação emergem, nesse contexto, como um elemento central para a compreensão das práticas alimentares e das respostas da criança frente à alimentação. Esses estilos refletem o clima emocional e as atitudes dos cuidadores durante as refeições, variando conforme os níveis de exigência e responsividade adotados (BIRCH; DAVISON, 2001; HUGHES et al., 2008). Evidências indicam que diferentes estilos parentais estão associados a distintos desfechos no comportamento alimentar infantil, podendo atuar como fatores de proteção ou de risco para o desenvolvimento de dificuldades alimentares (TAN et al., 2025; GRAMMER et al., 2022).

Apesar do reconhecimento da relevância dos estilos parentais na formação do comportamento alimentar e no manejo das DAPs, observa-se uma lacuna na literatura quanto à investigação dessa associação no contexto da hospitalização pediátrica. Além disso, persistem lacunas relacionadas à padronização metodológica para classificação dos estilos parentais, uma vez que diferentes estudos utilizam distintos pontos de corte para categorizar as dimensões de exigência e responsividade (GRAMMER et al., 2022; LÓPEZ et al., 2022).

Considerando a complexidade do ambiente hospitalar e sua influência sobre as práticas alimentares familiares, torna-se necessário investigar os estilos parentais de alimentação a partir de abordagens metodológicas que contemplem as particularidades desse ambiente, bem como analisar sua associação com as DAPs. Diante desse contexto, o objetivo do presente estudo é analisar a associação entre os estilos parentais de alimentação e as DAPs em crianças hospitalizadas, buscando contribuir para o entendimento mais aprofundado desse público e apoiar futuras iniciativas de pesquisa e práticas em saúde.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Cuidado do paciente pediátrico hospitalizado

A hospitalização infantil constitui um evento potencialmente estressor e traumático para a criança, uma vez que implica a ruptura abrupta de seu meio social e de suas atividades cotidianas (SANTOS et al., 2016). Esse processo é frequentemente acompanhado por longos períodos de internação, reinternações recorrentes e terapêuticas invasivas, muitas vezes associadas a efeitos indesejáveis do próprio tratamento. Somam-se a esse contexto as dificuldades decorrentes da separação de membros da família durante as internações, a interrupção da rotina diária, as limitações na compreensão do diagnóstico, o impacto financeiro sobre o núcleo familiar e a vivência de sentimentos como angústia, sofrimento, dor e o medo da possibilidade de morte (BEZERRA et al., 2021).

Diante desse cenário, a criança é constantemente demandada a se adaptar a um ambiente desconhecido e a uma nova rotina, marcada pela submissão repetida a procedimentos invasivos e dolorosos. No contexto hospitalar, as limitações para o brincar e para a realização de atividades próprias da infância — seja em função da condição clínica, seja pela restrição do espaço físico — podem intensificar o sofrimento físico e psíquico, comprometendo o bem-estar global da criança (FERREIRA et al., 2019).

Esses impactos tendem a ser ainda mais acentuados em crianças com condições crônicas complexas (CCC), que englobam doenças que demandam acompanhamento contínuo, envolvimento de múltiplos especialistas e uso recorrente de serviços hospitalares. Crianças com cardiopatias congênitas complexas, doenças neuromusculares, condições metabólicas raras e paralisia cerebral grave apresentam maior risco de complicações durante a internação, necessitando de cuidados especializados e atuação multiprofissional (FEUDTNER et al., 2000; COHEN et al., 2011; BERRY et al., 2012). O manejo dessas crianças é particularmente desafiador devido à presença de sintomas persistentes, ao uso de tecnologias de suporte — como sondas, traqueostomias e ventilação não invasiva — e ao impacto das comorbidades associadas. Ademais, hospitalizações prolongadas e recorrentes podem comprometer o desenvolvimento infantil, as interações sociais e a qualidade de vida, reforçando a necessidade de modelos de cuidado centrados na criança e na família (KAMBOJ et al., 2017; QUINONEZ et al., 2021; HUDSON et al., 2022).

Nesse contexto de elevada complexidade clínica, a alimentação durante a internação hospitalar emerge como um desafio adicional. Diversos sintomas associados às doenças ou aos tratamentos, como febre, náuseas, vômitos, diarreia, dor, incapacidade de se alimentar de forma independente e alterações no paladar decorrentes de efeitos colaterais de medicamentos, podem comprometer a aceitação alimentar da criança. Além disso, fatores ambientais e emocionais — como o afastamento da família, a irregularidade dos horários, a modificação do sabor e da apresentação dos alimentos em relação à rotina habitual e o estado emocional fragilizado — interferem negativamente na ingestão alimentar, aumentando o risco de desnutrição hospitalar (MORIMOTO, 2002). A redução do apetite e da ingestão de energia configura-se, assim, como um importante fator prognóstico, com repercussões diretas sobre a evolução clínica e a recuperação da criança (HAZZARD et al., 2021).

Para a família, a hospitalização infantil representa uma ruptura significativa da normalidade, marcada por insegurança no exercício da função parental, reorganização da dinâmica familiar, dificuldades financeiras e sofrimento emocional diante da condição do filho (ALMEIDA et al., 2006). A família é reconhecida como unidade primária de cuidado, constituindo um espaço de interação, apoio mútuo e construção de estratégias para enfrentar os desafios impostos pela doença e pela hospitalização (ROSSATO; BOER, 2002). Nesse sentido, pais e cuidadores buscam não apenas atender às necessidades físicas da criança, mas também preservar seu bem-estar emocional, integrando aspectos psicológicos e sociais ao cuidado cotidiano (MENEZES, 2013).

A alimentação assume papel central entre as preocupações familiares, dada sua relevância para a recuperação e manutenção da saúde da criança. No ambiente hospitalar, sintomas como náuseas, inapetência e desconforto intensificam as dificuldades alimentares e despertam ansiedade nos pais quanto à aceitação dos alimentos (OLIVEIRA et al., 2015). Ademais, os cuidadores desempenham papel ativo no processo de alimentação, sendo corresponsáveis pela oferta e pelo estímulo à ingestão adequada de nutrientes (ALMEIDA et al., 2006). Essa participação, entretanto, pode gerar tensões adicionais, especialmente diante das restrições impostas pelo contexto hospitalar. Em muitos casos, na tentativa de compensar tais limitações, os pais tendem a adotar posturas mais permissivas após a alta hospitalar, flexibilizando a oferta alimentar no ambiente domiciliar, o que pode repercutir nos padrões alimentares da criança (SUEIRO et al., 2019).

Evidências empíricas recentes têm investigado as práticas alimentares parentais no contexto da hospitalização pediátrica. Um estudo transversal realizado com pais de crianças hospitalizadas identificou elevada prevalência de práticas alimentares consideradas insatisfatórias, associadas a fatores como limitações físicas para alimentação, apetite reduzido no ambiente hospitalar, dificuldades alimentares durante a internação, manejo da alimentação durante procedimentos médicos, peso atual da criança e condições socioeconômicas. Os achados indicam que, durante a hospitalização, as práticas alimentares adotadas pelos cuidadores estão relacionadas a múltiplos fatores clínicos e contextuais próprios do ambiente hospitalar (SAMANTA, SHETTY, 2025).

3.2 Dificuldades alimentares pediátricas (DAPs)

As Dificuldades Alimentares Pediátricas (DAPs) são definidas como ingestão alimentar via oral prejudicada, inadequada para idade e estão associadas a disfunções clínicas, nutricionais, habilidades alimentares e/ou psicossociais (GODAY et al., 2019). Esta condição pode estar acompanhada de determinados comportamentos apresentados pela criança, como a diminuição na quantidade, variedade ou tipo de alimentos, assim como manifestações comportamentais e emocionais nos momentos de refeição, como recusa alimentar e respostas gastrointestinais como vômitos, diarreia e constipação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2022).

Os critérios para diagnóstico de DAPs são descritos no Quadro 1. As DAPs contemplam diversos âmbitos do processo da alimentação, sendo classificadas em: disfagia, defensividade oral, aversão alimentar, sensibilidade tátil, seletividade alimentar, déficit de desenvolvimento, “picky eating” (ingestão de variedade reduzida de alimentos) e outros problemas associados (BROWN, 2019; FISHBEIN; BENTON; STRUTHERS, 2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2022).

Quadro 1 – Critérios diagnósticos para Dificuldade Alimentar Pediátrica (DAP)

- 1) **Um distúrbio na ingestão oral de nutrientes, inapropriada para a idade, com duração de pelo menos duas semanas, associado a uma ou mais das seguintes condições:**
 - a) **Disfunção médica evidenciada por um dos seguintes:**
 - i) Comprometimento cardiorrespiratório durante ingestão oral;
 - ii) Aspiração ou pneumonite aspirativa recorrente.
 - b) **Disfunção nutricional evidenciada por um dos seguintes:**
 - i) Desnutrição;
 - ii) Deficiência nutricional específica ou ingestão significativamente restrita de um ou mais nutrientes, resultado de uma redução na diversidade dietética;
 - iii) Necessidade de nutrição enteral ou suplementação oral para manter o estado nutricional e/ou a hidratação.
 - c) **Disfunção da habilidade alimentar evidenciada por um dos seguintes:**
 - i) Necessidade de adaptação de textura de líquidos ou alimentos;
 - ii) Uso de posição ou equipamento que adaptem a alimentação;
 - iii) Uso de estratégias para adaptar a alimentação.
 - d) **Disfunção psicossocial evidenciada por um dos seguintes:**
 - i) Comportamento de fuga ativo ou passivo quando estiver se alimentando ou sendo alimentada;
 - ii) Manejo inapropriado do cuidador da alimentação e/ou da necessidade nutricional da criança;
 - iii) Ruptura do funcionamento social no contexto da alimentação;
 - iv) Ruptura da relação criança-cuidador associada à alimentação.
- 2) **Ausência de processos cognitivos consistentes com distúrbio alimentar e padrão de ingestão oral quando não é devido à falta de comida ou congruente com as normas culturais.**

Fonte: Adaptado de Goday et al. Pediatric Feeding Disorder – Consensus Definition and Conceptual Framework. JPGN, v68, 2019.

A manifestação das DAPs pode ser apresentada de forma ampla, sendo alguns dos principais sintomas: redução alimentar parcial ou total, dificuldade para sugar, engolir ou mastigar, vômitos, cólicas, incapacidade de avançar em diferentes texturas alimentares, atraso no desenvolvimento das competências de alimentação independente, birras e/ou problemas de comportamento durante as refeições, duração prolongada das refeições, necessidade de distração para aumentar a ingestão, duração prolongada na amamentação ou mamadeira, engasgo, aspiração, demonstração de dor ao deglutir e alimentação nociva (forçada e/ou persecutória) (SHARP et al., 2022; KERZNER et al., 2015; LEVINE et al., 2011; SPEYER et al., 2018).

Do ponto de vista etiológico, diversas condições clínicas podem aumentar a vulnerabilidade às DAPs. Alterações no trato gastrointestinal, disfunções cardiorrespiratórias e neurológicas, anomalias anatômicas, dificuldades na coordenação entre sucção, deglutição e respiração, fatores genéticos, atrasos no desenvolvimento motor e alterações no processamento sensorial estão entre os principais fatores associados (GODAY et al., 2019; JUNQUEIRA et al., 2021; SPEYER et al., 2018). Entretanto, para além das causas orgânicas, é fundamental considerar a interação de fatores biopsicossociais, incluindo o ambiente em

que a criança está inserida, as práticas alimentares familiares e as respostas comportamentais desenvolvidas ao longo do tempo (GODAY et al., 2019; SDRAVOU et al., 2021).

As crianças com DAPs apresentam, de modo geral, ingestão alimentar e hídrica reduzida em qualidade e quantidade, o que as coloca em risco para alterações do estado nutricional, deficiências de micronutrientes e desidratação. Estima-se que a prevalência de DAPs em crianças com desenvolvimento típico varie entre 25% e 45% (SILVERMAN et al., 2020), podendo alcançar até 80% entre crianças com doenças crônicas ou distúrbios do neurodesenvolvimento (PADOS et al., 2021; GODAY et al., 2019). Esses dados evidenciam a magnitude do problema e sua relevância clínica, especialmente em populações pediátricas vulneráveis.

As repercussões das DAPs podem variar de leves a graves, afetando dimensões nutricionais, psicológicas, sociais e comportamentais do desenvolvimento infantil. Crianças com DAPs apresentam maior risco de diagnóstico de transtornos emocionais e comportamentais, os quais podem ser identificados ainda na infância, incluindo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e deficiência intelectual (SHAN et al., 2021). Ademais, o envolvimento intenso dos cuidadores no manejo da alimentação, frequentemente marcado por tentativas repetidas de ampliar a variedade e a ingestão alimentar, pode gerar frustração, estresse e impacto negativo na dinâmica familiar. Dessa forma, as DAPs não afetam apenas a criança, mas também repercutem de maneira significativa na relação cuidador-criança e no funcionamento familiar como um todo (KERZNER et al., 2015; RAMOS et al., 2017).

Considerando que as DAPs representam uma condição cada vez mais frequente e desafiadora para cuidadores e profissionais de saúde envolvidos no cuidado pediátrico (SHARP et al., 2022; GODAY et al., 2019), torna-se essencial a identificação precoce desse quadro. O reconhecimento oportuno das DAPs possibilita a implementação de intervenções dietéticas e terapêuticas adequadas, incluindo ajustes na consistência dos alimentos, uso de suplementação nutricional, adoção de estratégias alternativas de alimentação e manejo comportamental centrado na família. Essas intervenções visam não apenas a recuperação do estado nutricional, mas também a promoção do desenvolvimento infantil e a melhoria da qualidade de vida da criança e de seus cuidadores.

Nesse sentido, compreender as DAPs exige também a análise dos padrões e determinantes do comportamento alimentar infantil, uma vez que aspectos comportamentais,

relacionais e contextuais exercem papel central tanto na manifestação quanto na manutenção dessas dificuldades.

3.3 Comportamento alimentar infantil

A infância constitui uma janela de oportunidades fundamental para a promoção da saúde, do aprendizado, do desenvolvimento e do bem-estar social e emocional, exercendo papel determinante na formação de hábitos que tendem a se perpetuar ao longo da vida adulta. Evidências da neurociência indicam que o cérebro infantil apresenta elevada plasticidade, caracterizando essa fase por intenso desenvolvimento cognitivo, emocional e social (UNICEF, 2018). As conexões neuronais estabelecidas nesse período formam a base estrutural para os processos de aprendizagem ao longo da vida, favorecendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais, bem como da capacidade intelectual, aptidões e competências. Nesse contexto, os padrões alimentares construídos na infância assumem especial relevância, uma vez que influenciam diretamente a consolidação do comportamento alimentar futuro (BIRCH; DOUB, 2014).

O comportamento alimentar refere-se ao modo como os indivíduos se relacionam com os alimentos, englobando escolhas, práticas, preferências e respostas associadas ao ato de se alimentar (LAUS, 2017). Essas respostas comportamentais exercem impacto direto sobre a qualidade de vida e, quando inadequadas ou disfuncionais, podem contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis ao longo do curso da vida (MACHADO; COTTA; SILVA, 2014). Assim, para a compreensão dos hábitos e preferências alimentares infantis, torna-se imprescindível reconhecer a complexa rede de influências que permeia o comportamento alimentar da criança.

Nesse sentido, Story et al. (2002) propõem um modelo ecológico que organiza os determinantes do comportamento alimentar em quatro grandes categorias. Os determinantes individuais referem-se às características próprias da criança, incluindo atitudes, crenças, conhecimentos, autoeficácia, preferências alimentares, bem como fatores biológicos e demográficos. Os determinantes interpessoais dizem respeito aos ambientes sociais mais próximos, como família, amigos e redes de pares, que influenciam as escolhas alimentares por meio de processos como modelagem, reforço, apoio social e normas percebidas. Os ambientes comunitários abrangem os contextos em que os alimentos são obtidos e consumidos, incluindo escolas, creches, restaurantes e estabelecimentos comerciais, cuja configuração física influencia a disponibilidade e a acessibilidade dos alimentos. Por fim, os

determinantes sociais exercem influência indireta, porém relevante, englobando fatores socioeconômicos, normas culturais, publicidade de alimentos e políticas públicas relacionadas à alimentação e à agricultura.

O comportamento alimentar infantil é inicialmente moldado no contexto familiar e, posteriormente, ampliado por processos psicossociais e culturais mais amplos (VENTURA; BIRCH, 2008). A interação cuidador-criança durante as refeições, associada às expectativas culturais, pode influenciar significativamente a forma como a criança se comporta frente à alimentação. Diversos fatores contribuem para esse processo, incluindo o estilo parental de alimentação, a composição da dieta familiar, as preferências alimentares de pais e filhos, as práticas parentais de alimentação, a disponibilidade de alimentos no domicílio, o consumo de refeições fora de casa, as crenças relacionadas à nutrição e a interpretação, por vezes inadequada, dos sinais de fome e saciedade da criança (SCAGLIONI et al., 2008).

Dessa forma, o ambiente familiar exerce impacto central no desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. Os adultos, enquanto principais referências nesse processo, desempenham papel fundamental ao oferecer modelos de comportamento alimentar, tornando a família o primeiro e mais importante aliado tanto em ações preventivas quanto em intervenções precoces. As práticas alimentares estabelecidas nesse contexto têm potencial para moldar o padrão dietético da criança e influenciar sua relação com a alimentação ao longo de toda a vida.

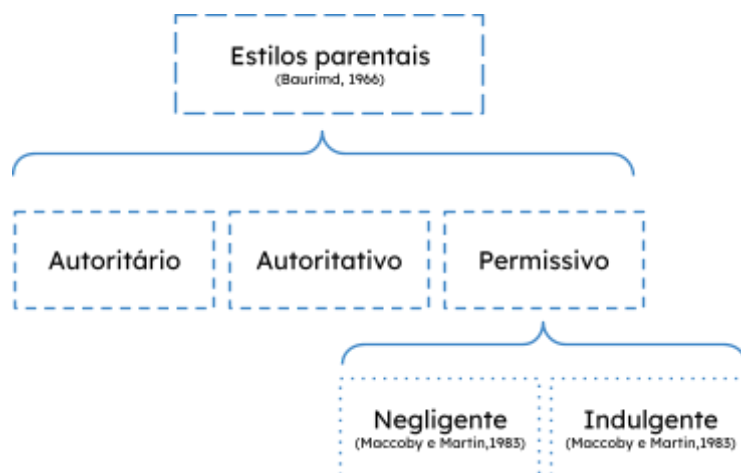
3.4 Estilos parentais na alimentação

A formação do comportamento alimentar tem início ainda na infância, nos primeiros meses de vida, e consolida-se ao longo do tempo como resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais (ALBUQUERQUE et al., 2016). Nesse processo, a família exerce papel central, sendo reconhecida como o primeiro e principal agente de socialização, responsável por transmitir valores, comportamentos e estilos de vida às crianças, frequentemente por meio de seus próprios hábitos alimentares. É no ambiente familiar que se iniciam as primeiras experiências com os alimentos e onde se estabelece a base do aprendizado alimentar (LARSON et al., 2009). Embora outros contextos sociais também influenciem a alimentação infantil, os familiares exercem papel primordial, especialmente nos primeiros anos de vida, por meio das práticas parentais mediadas pelos estilos parentais de alimentação (LAUS, 2017).

Os estilos parentais de alimentação são descritos na literatura como o conjunto de atitudes e comportamentos que caracterizam a interação entre pais ou cuidadores e a criança durante o momento das refeições. Esses estilos refletem não apenas práticas alimentares específicas, mas também o clima emocional em que tais práticas são aplicadas, constituindo uma característica relativamente estável dos cuidadores. De modo geral, variam conforme dimensões como afeto, responsividade, exigência e grau de controle exercido sobre o comportamento da criança (BIRCH; DAVISON, 2001; GRAMMER et al., 2022; TAN et al., 2025).

O estudo dos estilos parentais foi impulsionado pelo modelo proposto por Diana Baumrind, que inicialmente descreveu três tipos de estilos parentais: autoritativo, autoritário e permissivo. Posteriormente, Maccoby e Martin (1983) ampliaram essa proposta ao desmembrar o estilo permissivo em dois perfis distintos - indulgente e negligente - refinando a compreensão das diferentes combinações entre controle e afeto exercidas pelos cuidadores (Figura 1).

Figura 1 - Estilos parentais de alimentação segundo Baumrind e posteriormente modificados por Maccoby e Martin



Fonte: adaptado de Hughes et al. (2008)

De acordo com Hughes et al. (2008), os estilos parentais de alimentação podem ser compreendidos a partir de duas dimensões centrais: exigência e responsividade (Figura 2). A exigência refere-se ao grau em que os pais incentivam ou demandam a alimentação da criança, enquanto a responsividade diz respeito à forma como esse incentivo é realizado, considerando a sensibilidade às necessidades, sinais e emoções da criança. A combinação

dessas duas dimensões resulta na classificação dos quatro estilos parentais de alimentação: autoritativo, autoritário, indulgente e negligente (HUGHES et al., 2008).

Figura 2: Dimensões dos estilos parentais de alimentação



Fonte: adaptado de Hughes et al. (2008).

O estilo autoritativo caracteriza-se por altos níveis de exigência e responsividade. Cuidadores classificados nesse perfil estabelecem regras claras, comunicadas de forma aberta e coerente, valorizando o diálogo e a participação da criança. Comportamentos adequados são reconhecidos, enquanto atitudes inadequadas são corrigidas de maneira construtiva. Esses cuidadores demonstram afeto, são sensíveis às necessidades da criança e frequentemente consideram sua opinião no processo de tomada de decisão (TAN et al., 2025; GRAMMER et al., 2022). Evidências apontam que esse estilo está associado a desfechos positivos na alimentação infantil. Maranhão et al. (2017), em estudo transversal com 301 pré-escolares, identificaram o perfil responsivo materno como fator protetor para o desenvolvimento de DAPs, reforçando a relevância da interação mãe-filho no contexto alimentar. Adicionalmente, o estilo autoritativo mostrou associação com maior frequência de refeições realizadas em família ao longo da semana (BERGE et al., 2010).

O estilo autoritário é caracterizado por altos níveis de controle e baixa responsividade. Nesse perfil, os cuidadores adotam uma postura rígida, autocrática e pouco flexível, estabelecendo regras restritas sem a participação da criança. Há ênfase na obediência, no respeito à autoridade e na manutenção da ordem, sendo a punição frequentemente utilizada como estratégia de controle. O diálogo, a autonomia infantil e a sensibilidade às demandas da criança são pouco valorizados (TAN et al., 2025; GRAMMER et al., 2022). No contexto alimentar, esse estilo tende a se manifestar por controle excessivo, o que pode comprometer a

capacidade de autorregulação da criança. Estudos indicam que a restrição parental ao consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar está associada ao aumento da atenção e da preferência das crianças por esses alimentos (FISHER; BIRCH, 2000; TAN et al., 2025).

O estilo indulgente resulta da combinação entre baixo nível de controle e alta responsividade. Os cuidadores indulgentes demonstram afeto, comunicação e receptividade, porém estabelecem poucos limites ou regras, apresentando elevada tolerância e baixa exigência em relação ao comportamento da criança. Nesse contexto, as demandas da criança tendem a ser prontamente atendidas, com pouca estruturação das práticas alimentares (TAN et al., 2025). Esse estilo tem sido associado a desfechos desfavoráveis à saúde infantil, como maior prevalência de excesso de peso, obesidade, maior índice de massa corporal para a idade e menor ingestão de grãos integrais (HENNESSY et al., 2010; HUGHES et al., 2008; TOVAR et al., 2015). Um estudo feito com 296 famílias norte-americanas demonstrou que os filhos de pais indulgentes possuíam menor capacidade de “resposta à saciedade” (FRANKEL et al., 2014), e esta, por sua vez, foi associada à obesidade e ao consumo de alimentos ultraprocessados (VEDOVATO et al., 2021).

O estilo negligente caracteriza-se por baixos níveis tanto de controle quanto de responsividade. Cuidadores com esse perfil demonstram pouco envolvimento afetivo e reduzida supervisão do comportamento da criança, respondendo, em geral, apenas às necessidades básicas. Observa-se baixa interação social, distanciamento emocional e maior foco em interesses próprios, em detrimento das demandas da criança (TAN et al., 2025). Evidência sugere que mães com perfil negligente apresentam menor duração do aleitamento materno exclusivo e interação menos com os filhos durante as refeições, o que pode comprometer o desenvolvimento do comportamento alimentar infantil (MACHADO et al., 2018).

Considerando que pais e cuidadores exercem papel determinante na ingestão alimentar das crianças por meio de práticas parentais e estilos de interação, a identificação do estilo parental de alimentação torna-se fundamental. Esse reconhecimento possibilita o planejamento de intervenções comportamentais mais individualizadas e eficazes, respeitando o perfil do cuidador e favorecendo a promoção de práticas alimentares saudáveis e responsivas no contexto familiar.

4 JUSTIFICATIVA

A hospitalização constitui um evento potencialmente estressor, capaz de provocar alterações psicossociais relevantes na dinâmica criança–família. O afastamento do convívio familiar, a exposição a situações de sofrimento e a necessidade de adaptação a uma nova rotina impõem desafios adicionais à criança e aos seus cuidadores (SANTOS et al., 2016). Nesse contexto, a alimentação infantil frequentemente sofre modificações, tornando-se um foco recorrente de preocupação, uma vez que passa a ser associada diretamente ao estado de saúde e ao processo de recuperação da criança (OLIVEIRA et al., 2015; BEZERRA et al., 2021).

Essas mudanças no contexto alimentar podem intensificar ou desencadear DAPs, especialmente em crianças hospitalizadas. As DAPs apresentam caráter multifatorial e interativo, exigindo uma abordagem diagnóstica que considere aspectos motores orais, histórico alimentar e fatores comportamentais e interacionais. Suas repercussões ultrapassam a ingestão alimentar, podendo comprometer o crescimento, o estado nutricional, o desenvolvimento cognitivo e a qualidade das interações familiares, com impactos biopsicossociais para a criança e seus cuidadores (SHARP et al., 2022; GODAY et al., 2019).

Nesse cenário, o papel dos pais e cuidadores assume importância central, uma vez que influenciam diretamente as preferências e o padrão alimentar das crianças por meio de suas atitudes e práticas alimentares (TAN et al., 2025). Assim, o estilo parental de alimentação do cuidador principal torna-se um elemento relevante no manejo das DAPs, podendo favorecer ou perpetuar comportamentos alimentares disfuncionais (TAN et al., 2025).

Apesar do reconhecimento da relevância dos estilos parentais na formação do comportamento alimentar infantil, observa-se uma lacuna na literatura quanto à investigação de sua associação com as DAPs no contexto da hospitalização. A maioria dos estudos concentra-se em populações saudáveis ou em ambientes domiciliares, limitando a compreensão das especificidades das interações alimentares frente às demandas clínicas e emocionais do ambiente hospitalar.

Diante disso, o presente estudo justifica-se ao analisar os estilos parentais de alimentação e sua associação com as DAPs em crianças hospitalizadas, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de cuidado mais integradas e humanizadas, que considerem não apenas a condição clínica da criança, mas também o papel dos cuidadores e das interações alimentares nesse contexto.

5 HIPÓTESE DE PESQUISA

Estilos parentais caracterizados por alta responsividade são mais frequentes em crianças hospitalizadas com DAPs.

6 OBJETIVOS

6.1 Objetivo geral

Analisar os estilos parentais e associar às Dificuldades Alimentares Pediátricas em crianças hospitalizadas.

6.2 Objetivos específicos

- a) Identificar e caracterizar variáveis clínicas e nutricionais em crianças hospitalizadas;
- b) Caracterizar variáveis sociodemográficas de cuidadores de crianças hospitalizadas;
- c) Descrever o estilo parental de cuidadores de crianças hospitalizadas e analisar com os pontos de corte já existente na literatura;
- d) Comparar as dimensões dos estilos parentais de alimentação com variáveis sociodemográficas dos cuidadores e clínicas e nutricionais das crianças hospitalizadas;
- e) Identificar e descrever as crianças hospitalizadas com Dificuldades Alimentares Pediátricas;
- f) Comparar as dimensões dos estilos parentais de alimentação entre crianças hospitalizadas com Dificuldades Alimentares Pediátricas;

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta dissertação ampliam a compreensão sobre os estilos parentais de alimentação no contexto da hospitalização pediátrica, evidenciando que as práticas alimentares dos cuidadores são influenciadas por múltiplas dimensões que extrapolam classificações categóricas. Observou-se que essas práticas são moldadas não apenas por aspectos metodológicos relacionados à sua classificação, mas também pela complexidade clínica das crianças, fatores psicossociais e pela dinâmica relacional estabelecida entre cuidador e criança em um cenário de vulnerabilidade.

O primeiro estudo demonstrou que a tipologia dos estilos parentais é sensível ao ponto de corte adotado, resultando em variações na distribuição dos estilos, embora as associações entre exigência, responsividade e características das crianças e cuidadores tenham permanecido consistentes. Esses achados reforçam a importância de análises dimensionais das práticas parentais, que parecem captar com maior sensibilidade as particularidades do cuidado alimentar no contexto hospitalar.

O segundo estudo evidenciou associação entre os estilos parentais e as DAPs em crianças hospitalizadas, indicando que práticas caracterizadas por maior exigência e menor responsividade estiveram relacionadas à maior ocorrência e percepção dessas dificuldades, especialmente quanto à aceitação alimentar, introdução de novos alimentos e progressão de texturas. Embora a hipótese inicial considerasse maior frequência de estilos caracterizados por alta responsividade em crianças com DAPs, os resultados sugerem que, diante da instabilidade clínica e emocional da hospitalização, práticas mais controladoras podem emergir como estratégia dos cuidadores para garantir ingestão alimentar, ainda que possam contribuir para interações alimentares menos sensíveis.

A aplicação dos critérios diagnósticos propostos pelo Consenso Internacional de Dificuldades Alimentares Pediátricas representou um ponto central de reflexão neste estudo. Ao utilizar os critérios estabelecidos por Goday et al. (2019), observou-se que a maior parte da amostra poderia ser classificada como portadora de DAP, evidenciando a abrangência e sensibilidade do consenso. Essa experiência também demonstrou a necessidade de ampliação do olhar sobre a própria classificação das DAPs, especialmente em contextos de maior complexidade assistencial. A identificação de critérios diagnósticos não deve ser compreendida apenas como um processo de categorização, mas como uma oportunidade de compreender a singularidade das manifestações alimentares, suas causas subjacentes e seus desdobramentos funcionais. No contexto da hospitalização pediátrica, a elevada prevalência

de critérios compatíveis com DAPs sugere que a classificação precisa ser interpretada de forma contextualizada, considerando a trajetória clínica da criança, o momento do tratamento e as interações estabelecidas com seus cuidadores e com o ambiente hospitalar.

Além disso, os achados desta dissertação também contribuem para o debate metodológico ao questionar a aplicabilidade universal de pontos de corte fixos para classificação dos estilos parentais e ao sugerir que instrumentos diagnósticos e classificatórios devem ser interpretados à luz das especificidades das populações estudadas.

Do ponto de vista assistencial, os resultados do estudo evidenciaram a centralidade do cuidado materno no contexto da hospitalização pediátrica, destacando que, na maioria dos casos, as mães assumem o papel de cuidadoras principais, acumulando responsabilidades relacionadas ao manejo clínico, à alimentação e ao suporte emocional da criança. Esse protagonismo, embora represente um importante fator de proteção e vínculo, também pode resultar em significativa sobrecarga física e emocional, intensificada pelas demandas do ambiente hospitalar, pela insegurança frente ao estado de saúde da criança e pela necessidade de adaptação às rotinas institucionais. Compreender o cuidado alimentar no contexto hospitalar implica reconhecer a complexidade das experiências maternas e a necessidade de estratégias assistenciais que acolham as demandas emocionais e sociais dessas cuidadoras. Tais intervenções podem favorecer interações alimentares mais positivas e contribuir para o manejo das DAPs e para o desenvolvimento de habilidades alimentares adequadas.

Por fim, os resultados apresentados indicam a necessidade de investigações longitudinais que acompanhem essas crianças e seus cuidadores após a hospitalização, permitindo compreender a evolução das DAPs e suas repercussões no desenvolvimento infantil. Espera-se que esta dissertação contribua para o aprimoramento das práticas assistenciais e para o avanço do conhecimento científico sobre as dificuldades alimentares pediátricas em contextos hospitalares.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, Lusyanny Parente *et al.* Overweight relationship with dietary behavior and lifestyle in brazilian students. **Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria**, [S.L.], n. 1, p. 17-23, 28 fev. 2016. Fundación alimentación saludable.. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.12873/361parente>.
- ALMEIDA, Maria Inez et al. O ser mãe de criança com doença crônica: realizando cuidados complexos. **Escola Anna Nery**, v. 10, p. 36-46, 2006.
- ANTUNES, M. M. L.; SICHIERI, R.; SALLES-COSTA, R. Consumo alimentar de crianças menores de três anos residentes em área de alta prevalência de insegurança alimentar domiciliar. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 8, p. 1642–1650, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2010000800017>
- BAUMRIND, Diana. Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. **Child Development**, [S.L.], v. 37, n. 4, p. 887, dez. 1966. JSTOR. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2307/1126611>.
- BERGE, Jerica M. et al. Parenting Style and Family Meals: cross-sectional and 5-year longitudinal associations. **Journal Of The American Dietetic Association**, [S.L.], v. 110, n. 7, p. 1036-1042, jul. 2010. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jada.2010.04.011>
- BERRY, J. G.; et al. The landscape of medical care for children with medical complexity. **Pediatrics**, Springfield, v. 130, n. 6, p. 1–9, 2012.
- BEZERRA, Júlia Carmo; OLIVEIRA, Luciana Carla Barbosa de; MAIA, Eulália Maria Chaves. Stress and quality of life in children with chronic kidney disease hospitalized. **Psicologia, Saúde & Doença**, [S.L.], v. 17, n. 3, p. 382-388, 10 nov. 2021. Sociedad Portuguesa de Psicologia da Saúde. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15309/16psd170306>.
- BIRCH, Leann Lipps; DAVISON, Kirsten Krahnstoever. Family environmental factors influencing the developing behavioral controls of food intake and childhood overweight. **Pediatric Clinics Of North America**, [S.L.], v. 48, n. 4, p. 893-907, ago. 2001. Elsevier BV. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0031-3955\(05\)70347-3](http://dx.doi.org/10.1016/s0031-3955(05)70347-3)
- BIRCH, Leann L; DOUB, Allison e. Learning to eat: birth to age 2 y. **The American Journal Of Clinical Nutrition**, [S.L.], v. 99, n. 3, p. 723-728, 22 jan. 2014. Oxford University Press (OUP). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.113.069047>
- BORGES, Rogério Boff et al. Power and Sample Size for Health Researchers: uma ferramenta para cálculo de tamanho amostral e poder do teste voltado a pesquisadores da área da saúde. **Clinical & Biomedical Research**, [S.L.], v. 40, n. 4, apr. 2021. ISSN 2357-9730. Disponível em: <https://doi.org/10.22491/2357-9730.109542>.
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm
- BROWN, Callie L. Defining picky eating and its relationship to feeding behaviors and weight status. **Journal of Behavioral Medicine**, [S. l.], 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10865-019-00081w>

CAUDURO, Giovanna, REPPOLD, Caroline JT, PACHECO, Janaína TB. Adaptação Transcultural do Questionário de Estilos Parentais na Alimentação (QEPA). **Rev Avaliação Psicológica** [S.I.]. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15689/ap.2017.1603.12452>.

COHEN, E.; et al. Children with medical complexity: an emerging population for clinical and research initiatives. **Pediatrics**, Springfield, v. 127, n. 3, p. 529–538, 2011.

DAY, Steven M. et al. Growth patterns in a population of children and adolescents with cerebral palsy. **Developmental Medicine & Child Neurology**, [s. l.], v. 49, n. 3, p.167-171, mar. 2007. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1469-8749.2007.00167.x>.

CRUZ, L. B. da et al. Estado nutricional e fatores de risco para desnutrição no atendimento nutricional pediátrico da admissão hospitalar. **Clinical and Biomedical Research**, Porto Alegre, v. 29, n. 3, 2009. DOI: <https://doi.org/10.22491/2357-9730.8576>

DINIZ, Patricia Barcellos; FAGONDES, Simone Chaves; RAMSAY, Maria. Cross-cultural adaptation and validation of the Montreal children's hospital feeding scale into Brazilian Portuguese. **Revista Paulista de Pediatria**, [S. l.], v. 39, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2019377>

FERREIRA, Lucas Batista et. al. Cuidar de enfermagem às famílias de crianças e adolescentes hospitalizados. **Rev. Enferm UFPE**. [S.I.], v.13, n.1, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1005939>.

FEUDTNER, C.; et al. Pediatric complex chronic conditions classification system. **Pediatrics**, Springfield, v. 105, n. 1, p. 205–209, 2000.

FEUDTNER, C.; FEINSTEIN, J. A.; ZHONG, W.; HALL, M.; DAI, D. Pediatric complex chronic conditions classification system version 2: updated for ICD-10 and complex medical technology dependence and transplantation. **BMC Pediatrics**, v. 14, p. 199, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1471-2431-14-199>

FISHBEIN, Mark; BENTON, Kathryn; STRUTHERS, William. Mealtime disruption and caregiver stress in referrals to an outpatient feeding clinic. **Journal of Parenteral and Enteral Nutrition**, [S. l.], v. 40, n. 5, p. 636–645, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0148607114543832>

FISHER, Jennifer Orlet; BIRCH, Leann Lipps. Parents' Restrictive Feeding Practices are Associated with Young Girls' Negative Self-evaluation of Eating. **Journal Of The American Dietetic Association**, [S.L.], v. 100, n. 11, p. 1341-1346, nov. 2000. Elsevier BV. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0002-8223\(00\)00378-3](http://dx.doi.org/10.1016/s0002-8223(00)00378-3)

FRANKEL, Leslie A. et al. Parents' perceptions of preschool children's ability to regulate eating. Feeding style differences. **Appetite**, [S.L.], v. 76, p. 166-174, maio 2014. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2014.01.077>

GODAY, Praveen S. et al. Pediatric Feeding Disorder: Consensus Definition and Conceptual Framework. **Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition**, [S. l.], v. 68, n. 1, p. 124–129, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000002188>

GRAMMER, A. C.; BALANTEKIN, K. N.; BARCH, D. M.; MARKSON, L.; WILFLEY, D. E. Parent-child influences on child eating self-regulation and weight in early childhood: a systematic review. **Appetite**, v. 168, p. 105733, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105733>

HAZZARD, Emily et al. Healthcare professionals' perspectives on the role of dietitians within multidisciplinary head and neck cancer teams: a qualitative multi-site study. **Nutrition & Dietetics**, v. 78, n. 5, p. 506-515, 2021.

HARRIS, P. A.; TAYLOR, R.; THIELKE, R.; PAYNE, J.; GONZALEZ, N.; CONDE, J. G. Research electronic data capture (REDCap)—A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. **Journal of Biomedical Informatics**, v. 42, n. 2, p. 377–381, 2009.

HENNESSY, Erin et al. Parent behavior and child weight status among a diverse group of underserved rural families. **Appetite**, [S.L.], v. 54, n. 2, p. 369-377, abr. 2010. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2010.01.004>

HUDSON, S. M.; et al. Children with medical complexity: A scoping review of interventions to support care in the hospital and at home. **Journal of Pediatric Nursing**, Philadelphia, v. 64, p. 1–11, 2022.

HUGHES, Sheryl O. *et al.* Caregiver's Feeding Styles Questionnaire: establishing cutoff points. **Appetite**, London, v. 58, n. 1, p. 393-395, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.11.01>

HUGHES, Sheryl O. *et al.* Indulgent Feeding Style and Children's Weight Status in Preschool. **Journal Of Developmental & Behavioral Pediatrics**, [S.L.], v. 29, n. 5, p. 403-410, out. 2008. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1097/dbp.0b013e318182a976>.

JUNQUEIRA, Patrícia et al. Relationship between anthropometric parameters and sensory processing in typically developing brazilian children with a pediatric feeding disorder. **Nutrients**, [S. l.], v. 13, n. 7, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu13072253>

KAMBOJ, R. D.; et al. Pediatric chronic complex conditions and hospital outcomes. **Hospital Pediatrics**, Elk Grove Village, v. 7, n. 10, p. 593–600, 2017.

KERZNER, Benny et al. A practical approach to classifying and managing feeding difficulties. **Pediatrics**, [S. l.], v. 135, n. 2, p. 344–353, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1542/peds.2014-1630>

KRICK, Jackie et al. Pattern of growth in children with cerebral palsy. **Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics**, [s. l.], v. 96, n. 7, p. 680-685, jul. 1996. Disponível em: <https://www.jandonline.org/action/showPdf?pii=S0002-8223%2896%2900188-5>.

LAUS, Maria Fernanda *et al.* Determinantes ambientais do comportamento alimentar. In: DIEZ-GARCIA, Rosa Wanda; CERVATO-MANCUSO, Ana Maria (org.). **Mudanças alimentares e Educação Alimentar e Nutricional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. p.118 - 138.

LARSON, Nicole *et al.* A Review of Environmental Influences on Food Choices. **Annals Of Behavioral Medicine**, [S.L.], v. 38, n. 1, p. 56-73, 3 out. 2009. Oxford University Press (OUP). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s12160-009-9120-9>

LEVINE, Arie et al. Screening criteria for diagnosis of infantile feeding disorders as a cause of poor feeding or food refusal. **Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition**, [S. l.], v. 52, n. 5, p. 563–568, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3181ff72d2>

LÓPEZ, B. A.; NICHOLSON, J. S.; GARCÍA, R. N.; JOHNSON, H. R.; POWER, T. G.; HUGHES, S. O. Control and chaos: caregiver's basic psychological need frustration is associated with the socioemotional climate when feeding. **Eating Behaviors**, v. 46, p. 101659, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2022.101659>

MACHADO, Juliana Costa; COTTA, Rosângela Minardi Mitre, SILVA; Luciana Saraiva da. Abordagem do desvio positivo para a mudança de comportamento alimentar: revisão sistemática. **Rev Panam Salud Publica**, [S.L.], v. 36, n. 2, p 134–140, 2014.

MACHADO, M. M. T. et al. Parental feeding styles and their association with breastfeeding and complementary feeding practices. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 36, n. 3, p. 287–294, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2018;36;3;00011>

MACCOBY, E; & MARTIN, J. A. .Socialization in the context of the family: parent-child interaction. *Handbook of Child Psychology*, New York: Wiley, v. 4, p:1-101, 1983.

MARANHÃO, H. S.; et al. Dificuldades Alimentares em pré-escolares, práticas alimentares pregressas e estado nutricional. **Revista Paulista de Pediatria**, Natal, v. 36, n. 1, p. 45-51, 30 out. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2018;36;1;00004>

RAHILL, Stephanie et al. A review of the influence of fathers on children's eating behaviours and dietary intake. **Appetite**, v. 147, p. 104540, 2020.

MENEZES, Marina. A Criança e sua rede familiar: significações do processo de hospitalização. 2010. 411 f. Tese (Doutorado) - Curso de Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

MORIMOTO, I. M. I. Melhoria da Qualidade na Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar: Um Modelo Prático. 2002. 262 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós - Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

MULLEN, R.; SCHOOLING, T. The National Outcomes Measurement System for Pediatric Speech-Language Pathology. **Language, Speech, and Hearing Services in Schools**, [s. l.], v. 41, n. 1, p. 44–60, 2010.

OLIVEIRA, Mariana Rebouças de, et al. Câncer infantil: percepções de cuidadoras sobre alimentação, dinâmica familiar e emocional. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, [S.L.], v. 28, n. 4, p. 560-567, 30 dez. 2015. Fundacao Edson Queiroz. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5020/18061230.2015.p560>.

QUINONEZ, R. B.; et al. Pediatric complex chronic conditions: Trends and challenges. **Pediatrics**, Springfield, v. 148, n. 5, p. e2021052590, 2021.

RAMA, Cristiane G.; BERNARDES, Fernanda B.; LEFTON-GREIF, Maureen A.; LEVY, Deborah S.; BOSA, Vera L. Translation, cultural adaptation, reliability, and validity evidence of the Feeding/Swallowing Impact Survey (FS-IS) to Brazilian Portuguese. **Dysphagia**, v. 37, n. 5, p. 1226-1237, 2022. DOI: 10.1007/s00455-021-10383-4

RAMOS, Cláudia C. et al. Delayed development of feeding skills in children with feeding difficulties-cross-sectional study in a Brazilian reference center. **Frontiers in Pediatrics**, [S. l.], v. 5, n. October, p. 1–8, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fped.2017.00229>

ROSSATO, Angélica Laurini; BOER, Noemi. O impacto emocional da hospitalização em crianças de seis a dez anos. **Disciplinarum Scientia**, v. 3, n. 1, p. 145-164, 2002.

SAMANTA, S.; SHETTY, A. P. Assessing child feeding practices among parents of hospitalized children and their associated factors in a tertiary care hospital in Bhubaneswar, India: a descriptive cross-sectional study. **Cureus**, [S.l.], v. 17, n. 12, e98420, 2025. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.98420>

SANTOS, Priscila Mattos dos et al. Os cuidados de enfermagem na percepção da criança hospitalizada. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S.L.], v. 69, n. 4, p. 646-653, ago. 2016. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2016690405i>.

SASSI, F. C.; MEDEIROS, G. C.; ZAMBON, L. S.; ZILBERSTEIN, B.; ANDRADE, C. R. F. Avaliação e classificação da disfagia pós-extubação em pacientes críticos. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 45, n. 3, e1687, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20181687>

SCAGLIONI, Silvia et al. Influence of parental attitudes in the development of children eating behavior. **British Journal Of Nutrition**, [S.L.], v. 99, n. 1, p. 22-25, fev. 2008. Cambridge University Press (CUP). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1017/s0007114508892471>.

SDRAVOU, Katerina et al. Feeding problems in typically developing young children, a population-based study. **Children**, [S. l.], v. 8, n. 5, p. 1–15, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/children8050388>

SHAN, Hongyun et al. Feeding and Eating Disorder and Risk of Subsequent Neurodevelopmental Disorders: A Population-Based Cohort Study. **Frontiers in Pediatrics**, [S. l.], v. 9, n. September, p. 1–8, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fped.2021.671631>

SHARP, W. G. et al. Toward Better Understanding of Pediatric Feeding Disorder: A Proposed Framework for Patient Characterization. **Journal of pediatric gastroenterology and nutrition**, United States, v. 75, n. 3, p. 351–355, 2022.

SILVERMAN, A. H. et al. Psychometric Properties of the Infant and Child Feeding Questionnaire. **The Journal of Pediatrics**, [s. l.], v. 223, p. 81-86.e2, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Guia de orientações - Dificuldades alimentares/ Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Nutrologia. São Paulo: SBP, 2022.

SPEYER, Renée *et al.* Psychometric Characteristics of Non-instrumental Swallowing and Feeding Assessments in Pediatrics: A Systematic Review Using COSMIN. **Dysphagia**, [S. l.], v. 33, n. 1, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00455-017-9835-x>.

STORY, Mary T. et al. Management of Child and Adolescent Obesity: attitudes, barriers, skills, and training needs among health care professionals. **Pediatrics**, [S.L.], v. 110, n. 1, p. 210-214, 1 jul. 2002. American Academy of Pediatrics (AAP). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1542/peds.110.s1.210>

SUEIRO, Isis de Moura et al. Fatores intervenientes para o cuidado de enfermagem na alimentação da criança hospitalizada em quimioterapia. **Revista de Enfermagem da Ufsm**, [S.L.], v. 9, p. 1-19, 10 set. 2019. Universidad Federal de Santa Maria. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5902/2179769231138>.

TAN, R.; NG, N. B. H.; NG, J. Q. X.; AW, M. M.; SHOREY, S. Exploration of the relationship between caregiver feeding styles and paediatric feeding behaviours: a case control study in Singapore. **Appetite**, v. 214, p. 108187, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2025.108187>

TOVAR, Alison et al. Low demanding parental feeding style is associated with low consumption of whole grains among children of recent immigrants. **Appetite**, [S.L.], v. 95, p. 211-218, dez. 2015. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2015.06.006>

UNICEF. Desenvolvimento Infantil - 2018. Brasília (DF): Escritório da Representação do UNICEF no Brasil; 2018.

VEDOVATO, Gabriela Milhassi et al. Ultra-processed food consumption, appetitive traits and BMI in children: a prospective study. **British Journal Of Nutrition**, [S.L.], v. 125, n. 12, p. 1427-1436, 23 set. 2020. Cambridge University Press (CUP). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1017/s0007114520003712>

VENTURA, Alison K; BIRCH, Leann L. Does parenting affect children's eating and weight status? **International Journal Of Behavioral Nutrition And Physical Activity**, [S.L.], v. 5, n. 1, p. 15, 2008. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1186/1479-5868-5-15>

VILLAR, J. et al. Postnatal growth standards for preterm infants: the Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21 st Project. **The Lancet Global Health**, [s.l.], v. 3, n. 11, p. e681–e691, 1 Nov. 2015. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214109X15001631>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Who child growth standards: length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age. Methods and development. WHO (nonserial publication). Geneva, Switzerland: 2006. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/924154693X>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Growth reference data for 5-19 years. Geneva: 2007. Disponível em: <https://www.who.int/toolkits/growth-reference-data-for-5to19-years>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health for the world's adolescents: a second chance in the second decade. Geneva: WHO, 2014.

ZEMEL, Babette S. et al. Growth Charts for Children With Down Syndrome in the United States. **Pediatrics**, [s. l.], v. 136, n. 5, p. 1204-1211, nov. 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5451269/>

APÊNDICES

APÊNDICE A - Questionário sociodemográfico, clínico e nutricional

Data da coleta: __/__/__	Coletador:	ID:
Dados da criança Coletar os dados a seguir no prontuário do paciente.		Código
Número do prontuário		pront ____
Idade (em anos para maiores de 24 meses)		idmeses __
Idade (em meses até 24 meses)		idanos __
Idade corrigida (se necessário até 24 meses)		idc __
Sexo	☐ Feminino (0) ☐ Masculino (1)	sexo _
Cor da pele/raça da criança (conforme prontuário)	☐ Preta (0) ☐ Parda (1) ☐ Branca (2) ☐ Indígena (3) ☐ Amarela (5)	cor _
Data da internação	__/__/__	dataint _ _ _
Motivo da internação		motint __
Diagnóstico principal (CID)		cid ____
O paciente já foi hospitalizado anteriormente?	☐ Sim (0) ☐ Não (1)	hospant _
Perfil de hospitalização	☐ Agudo (0) ☐ Crônico (1)	perfilhosp _
Dados de nascimento Coletar os dados a seguir na carteirinha da criança (se disponível) ou no prontuário.		
Data do nascimento	__/__/__	dn _ _ _
Idade gestacional (em semanas)	__	ig __
Peso ao nascer (em kg)	__ _ _	pn __ _ _
Comprimento ao nascer (em centímetros)	__	cn __

Classificação do peso ao nascer	☐ PIG (pequeno para idade gestacional <2500g) (0) ☐ AIG (adequado para idade gestacional $\geq$ 2500g até <4000g) (1) ☐ GIG (grande para idade gestacional $\geq$ 4000g) (2)	classifpn _
Dados do cuidador O objetivo do questionário a seguir é coletar informações sobre o cuidador e dados socioeconômicos da família. * Instruções: - Crie um ambiente acolhedor. - Explique o propósito do questionário. - Faça as perguntas de forma clara, lendo para o entrevistado as alternativas e ouça atentamente. - Anote cuidadosamente as respostas.		
Data de nascimento do cuidador	__/__/__	dncuid _/_/_
Sexo	☐ Feminino (0) ☐ Masculino (1)	sexocuid _
Com qual cor ou raça você se identifica?	☐ Preta (0) ☐ Parda (1) ☐ Branca (2) ☐ Indígena (3) ☐ Amarela (5)	corcuid _
Qual o seu parentesco com paciente?	☐ Mãe (0) ☐ Pai (1) ☐ Irmão (ã) (2) ☐ Avó (ô) (3) ☐ Tio (a) (4) ☐ Outro (5)	parent _
Quem é considerado o cuidador principal do paciente?	☐ Apenas a mãe (0) ☐ Apenas o pai (1) ☐ Mãe e pai (2) ☐ Avós (ôs) (3) ☐ Tios (as) (4) ☐ Outro (5)	cuidprinc _
Qual sua situação conjugal?	☐ Solteiro(a) (0) ☐ Casado(a) ou com companheiro (a) (1)	sitconj _
Você mora com o paciente?	☐ Sim (0) ☐ Não (1)	moracom _
Se mora com o paciente, quantas pessoas moram na casa? (contando você e o paciente)	☐ 2 pessoas (0) ☐ 3 pessoas (1) ☐ 4 ou mais pessoas (2)	moradcasa _
Qual a renda mensal da família, incluindo a renda de trabalho mais aposentadoria, em quantidades de Salários Mínimos?	☐ < 1 SM (< R\$1.302,00) (0) ☐ 1 a 2 SM (R\$ 1.302,00 a R\$ 2.604,00) (1) ☐ 2 A 3 SM (R\$ 2.604,00 a R\$ 3.906,00) (2) ☐ 3 a 4 SM (R\$ 3.906,00 a R\$ 5.208,00) (3) ☐ 4 a 5 SM (R\$ 5.208,00 a R\$ 6.510,00) (4)	renda _

	() 5 ou +SM (> R\$ 6.510,00) (5) () Não sabe informar (6)	
A família participa de programas governamentais (Bolsa Família, BPC, etc)?	() Sim (0) () Não (1)	benef _
Quantos anos completos de estudo você tem?	_____ anos	estudo _
Dietoterapia O objetivo do questionário a seguir é coletar informações sobre a alimentação de crianças, identificando dificuldades e práticas nutricionais. * Instruções: - Crie um ambiente acolhedor. - Explique o propósito do questionário. - Faça as perguntas de forma clara, lendo para o entrevistado as alternativas e ouça atentamente. - Anote cuidadosamente as respostas.		
Qual a via de alimentação atual da criança?	() via oral (0) () via oral + enteral/parenteral (1)	viaalim _
Consistência da dieta atual (coletar no prontuário)	() Normal (0) () Pastosa (1) () Liquidificada (3) () Branda (4) () Líquida (5) () Sem resíduos (6)	dieta _
O paciente faz uso de chupeta atualmente?	() Sim (0) () Não (1)	chupet _
O paciente faz uso de mamadeira atual?	() Sim (0) () Não (1)	mmd _
Já usou sonda para alimentação alguma vez?	() Sim (0) () Não (1)	sonda _
Quando iniciou a introdução alimentar?	() < 4 meses (0) () ≥ 4 meses e < 6 meses (1) () ≥ 6 meses (2)	ia _
O paciente recebeu leite materno?	() Sim (0) () Não (1)	lm _
Se sim, até que idade?	() Até 1 mês (0) () Até 6 meses (1) () > 6 meses (2)	idleitemat _
		textura _

A criança apresenta dificuldade para avançar/progredir nas texturas/consistências alimentares?	() Sim (0) () Não (1)	
A criança apresenta resistência para experimentar novos alimentos?	() Sim (0) () Não (1)	resistalim_
Se sim, qual foi sua conduta nessa situação?	() Não ofertou o alimento novamente (0) () Ofertou mais algumas vezes e a criança não aceitou (1) () Ofertou mais algumas vezes e a criança aceitou (2) () Não se aplica (Marcar não se aplica, caso a resposta anterior tenha sido não) (3)	conduta_
A criança apresenta limitações e/ou só realiza consumo de certos tipos de alimentos?	[] Não (0) [] Textura (crocante, macio, cremoso, etc) (1) [] Consistência (pastoso, líquidos, sólidos, etc.) (2) [] Temperatura (quente, frio, morno, etc) (3) [] Cores (3) [] Grupos alimentares (grãos, carnes, leite e derivados, ultraprocessados, etc) (4) [] Outro (5)	limitac_
Na sua percepção, em relação à alimentação, a criança:	() Aceita bem os alimentos (0) () Possui dificuldade para aceitar alguns alimentos (1) () Possui dificuldade de aceitar vários alimentos (2)	aceitalim_
A criança tem diagnóstico de disfagia?	() Sim (0) () Não (1)	disf_
A criança já fez ou faz acompanhamento com fonoaudiólogo por questões alimentares?	() Sim (0) () Não (1)	fono_

Dados antropométricos Colete os dados antropométricos na avaliação nutricional do paciente no prontuário.		
Peso atual (em kg)	---	pa ---
Estatura/comprimento (em centímetros)	---	est ---
IMC/I (escore z)	---	imci ---
P/I (escore z)	---	pi ---
E/I (escore z)	---	ei ---
Classificação do estado nutricional	☐ Baixo peso para idade (0) ☐ Baixa estatura para idade (1) ☐ Eutrófico (2) ☐ Risco de sobrepeso (3) ☐ Sobrepeso (4) ☐ Obesidade (5)	estnut _

APÊNDICE B - Termo de consentimento para menores de seis anos**TCLE PARA RESPONSÁVEIS - PACIENTE MENORES DE SEIS ANOS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO**

Nº do projeto GPPG ou CAAE: 65500222300005327

Título do Projeto: Estilos parentais na alimentação em crianças hospitalizadas com dificuldades alimentares pediátricas.

O(A) paciente pelo qual você é responsável está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é analisar a associação entre os estilos parentais de crianças hospitalizadas e as dificuldades alimentares pediátricas. Esta pesquisa está sendo realizada pelo setor de nutrição e dietética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você autorizar, a participação na pesquisa envolverá responder questionários com informações sobre você e o paciente.

A participação na pesquisa possui risco mínimo aos convidados, sendo eles relacionados à perda de confidencialidade das informações fornecidas e desconforto pelo tempo de resposta à escala. Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são auxiliar na compreensão das relações entre cuidadores e crianças no momento das refeições.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não autorizar, ou ainda, desistir da participação e retirar sua autorização, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que a pessoa recebe ou poderá vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante da participação na pesquisa, o participante receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome ou da pessoa pela qual você é responsável não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Vera Lúcia Bosa, pelo telefone (51) 996830417, com o pesquisador Luísa Rebechi Zampieri, pelo telefone (54) 999596377, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 33596246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do responsável do paciente

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Assinatura

Local e Data: _____ / ____ / ____

APÊNDICE C - Termo de Assentimento para maiores de seis anos

TALE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (MAIORES QUE 6 ANOS E MENORES DE 18 ANOS) E PARA LEGALMENTE INCAPAZ

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O assentimento informado para a criança/adolescente não substitui a necessidade de consentimento informado dos pais e/ou responsáveis. O assentimento assinado pela criança demonstra a sua cooperação na pesquisa.

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é analisar a associação entre os estilos parentais de crianças hospitalizadas e as dificuldades alimentares pediátricas. Esta pesquisa está sendo realizada pelo setor de Nutrição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Seus pais e/ou responsáveis permitiram que você participasse deste estudo. Com esta pesquisa, queremos saber informações a respeito da sua alimentação. Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 6 meses a 14 anos de idade. A pesquisa será feita no/a Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde as crianças irão acompanhar seus pais e responder alguns questionários. Para isso, serão usados questionários padronizados e validados, que são considerados seguros, mas é possível ocorrer risco de perda de confidencialidade e cansaço ao responder as perguntas. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones que estão informados no final do texto; mas há coisas boas que podem acontecer como ajudar a identificar a prevalência de dificuldades alimentares em crianças hospitalizadas, sendo uma etapa de um estudo que tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta de triagem para rastrear dificuldades alimentares.

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados em artigos científicos, mas sem identificar as crianças que participaram.

Se você ou os responsáveis por você tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do participante, ou riscos relacionados ao estudo, você deve contatar o(a) responsável por esta pesquisa, Vera Lúcia Bosa, pelo telefone (51) 996830417, com o pesquisador Luísa Rebechi Zampieri, pelo telefone (54) 999596377, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 33596246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Agradecemos a sua autorização e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO

Eu _____ aceito participar da pesquisa sobre os estilos parentais na alimentação em crianças hospitalizadas com dificuldades alimentares pediátricas.

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.

Porto Alegre, ____ de _____ de _____.

Assinatura do participante

Assinatura do coordenador da pesquisa

APÊNDICE D - Termo de consentimento para cuidadores**TCLE PARA RESPONSÁVEIS - CUIDADOR
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO**

Nº do projeto GPPG ou CAAE: 65500222300005327

Título do Projeto: Estilos parentais na alimentação em crianças hospitalizadas com dificuldades alimentares pediátricas

Você está sendo convidada(o) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é analisar a associação entre os estilos parentais de crianças hospitalizadas e as dificuldades alimentares pediátricas.

Se você autorizar, a participação na pesquisa envolverá responder questionários com informações sobre você e o paciente. A participação na pesquisa possui risco mínimo aos convidados, sendo eles relacionados à perda de confidencialidade das informações fornecidas e desconforto pelo tempo de resposta à escala.

Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são auxiliar na compreensão das relações entre cuidadores e crianças no momento das refeições. A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não autorizar, ou ainda, desistir da participação e retirar sua autorização, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que a pessoa recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante da participação na pesquisa, o participante receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome ou da pessoa pela qual você é responsável não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Vera Lúcia Bosa, pelo telefone (51) 996830417, com o pesquisador Luísa Rebechi Zampieri, pelo telefone (54) 999596377, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 33596246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do responsável do paciente

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data:

_____/_____/_____

ANEXOS

ANEXO 1 - Questionário de Estilos Parentais na Alimentação

Questionário de Estilos Educativos Parentais na Alimentação					
Este questionário tem como objetivo conhecer a forma como você interage com seu (sua) filho (a) na hora da refeição. Circule a resposta que melhor descreve a frequência com que essas situações ocorrem. Se você não tem certeza, circule a resposta que mais se aproxima da forma como você interage com seu (sua) filho (a), em cada situação descrita.					
QUANTAS VEZES DURANTE A REFEIÇÃO VOCÊ:	Nenhuma	Poucas Vezes	Às vezes	Muitas Vezes	Sempre
1) Usa de força física com a criança para que ela coma (por exemplo, fazendo com que a criança fique na cadeira para comer).	☐	☐	☐	☐	☐
2) Promete algo à criança, que não seja comida, como recompensa por comer (por exemplo, "se você comer o feijão, podemos jogar bola depois do almoço").	☐	☐	☐	☐	☐
3) Incentiva a criança a comer, "enfeitando" a comida para torná-la mais interessante (por exemplo, fazendo figuras/desenhos com os legumes ou verduras).	☐	☐	☐	☐	☐
4) Faz perguntas para a criança sobre a comida, durante a refeição (por exemplo, pergunta à criança se a comida está gostosa)	☐	☐	☐	☐	☐
5) Pede para a criança comer, pelo menos, um pouco da comida que está no prato	☐	☐	☐	☐	☐
6) Explica os benefícios da comida para que a criança coma (por exemplo, "o leite é bom para a sua saúde, porque ele vai fazer você ficar forte	☐	☐	☐	☐	☐
7) Diz algo à criança que demonstre a sua desaprovação pelo fato dela não ter comido a refeição.	☐	☐	☐	☐	☐
8) Permite que a criança escolha o que ela quer comer na refeição, entre os alimentos que já estão servidos	☐	☐	☐	☐	☐
9) Elogia a criança quando ela come (por exemplo, "Que menino(a) legal! Você está comendo o seu feijão!").	☐	☐	☐	☐	☐

QUANTAS VEZES DURANTE A REFEIÇÃO VOCÊ:					
	Nenhuma	Poucas Vezes	Às vezes	Muitas Vezes	Sempre
10) Sugere que a criança coma, dizendo, por exemplo, "a comida está esfriando"	☐	☐	☐	☐	☐
11) Apressa a criança no momento da refeição (por exemplo, fala para a criança: "Vamos mais rápido, coma logo a sua comida").	☐	☐	☐	☐	☐
12) Diz para a criança que irá tirar alguma coisa dela, se ela não comer a comida (por exemplo, "Se você não comer a comida não vai brincar depois do jantar").	☐	☐	☐	☐	☐
13) Diz para a criança comer algum dos alimentos que está no prato (por exemplo, "coma o macarrão").	☐	☐	☐	☐	☐
14) Avisa a criança que vai tirar dela algum alimento, se ela não comer a refeição (por ex "Se você não comer, você não vai ganhar a sobremesa").	☐	☐	☐	☐	☐
15) Diz alguma coisa positiva sobre a comida que a criança está comendo, durante a refeição (por exemplo, "como está gostoso o arroz")	☐	☐	☐	☐	☐
16) Dá comida na boca da criança para que ela coma a refeição.	☐	☐	☐	☐	☐
17) Ajuda a criança a comer durante a refeição (por exemplo, cortando o alimento em pedaços menores).	☐	☐	☐	☐	☐
18) Incentiva a criança a comer usando outros alimentos como recompensa (por exemplo: "Se você comer, você vai ganhar a sobremesa").	☐	☐	☐	☐	☐
19) Implora para que a criança coma a refeição	☐	☐	☐	☐	☐

ANEXO 2 - Escala Brasileira de Alimentação Infantil

Escala Brasileira de Alimentação Infantil (EBAI)							
Por favor, circule o número que corresponda a cada item. Observe que o significado dos números varia, não estão sempre na mesma ordem. Por favor, leia cada pergunta com atenção. Obrigada.							
1. O que você acha dos momentos de refeições com a sua criança?	1 Muito difícil	2	3	4	5	6	7 Fácil
2. Quão preocupado você está com a alimentação da sua criança?	1 Não estou preocupado	2	3	4	5	6	7 Estou muito preocupado
3. Quanto de apetite (fome) sua criança tem?	1 Nunca tem fome	2	3	4	5	6	7 Tem um bom apetite
4. Quando a sua criança começa a se recusar a comer durante as refeições?	1 No início da refeição	2	3	4	5	6	7 No fim da refeição
5. Quanto tempo (em minutos) dura a refeição da sua criança?	1 1-10	2 11-20	3 21-30	4 31-40	5 41-50	6 51-60	7 >60 min
6. Como a sua criança se comporta durante a refeição?	1 Se comportaria bem	2	3	4	5	6	7 Faz grande bagunça, faz birra, manha
7. A sua criança náuseia, cospe ou vomita com algum tipo de alimento?	1 Nunca	2	3	4	5	6	7 Na maioria das vezes
8. A sua criança fica com a comida parada na boca sem engolir?	1 Na maioria das vezes	2	3	4	5	6	7 Nunca
9. Você precisa ir atrás da sua criança ou usar distrações (como por exemplo: brinquedos, TV) durante a refeição para que ela coma?	1 Nunca	2	3	4	5	6	7 Na maioria das vezes
10. Você precisa forçar a sua criança a comer ou beber?	1 Na maioria das vezes	2	3	4	5	6	7 Nunca
11. Como é a habilidade de mastigação (ou sucção da sua criança)?	1 Boa	2	3	4	5	6	7 Muito ruim
12. O que você acha do crescimento da sua criança?	1 Crescendo pouco	2	3	4	5	6	7 Crescendo bem
13. Como a alimentação da sua criança influencia a sua relação com ela?	1 De forma muito negativa	2	3	4	5	6	7 Não influencia nada
14. Como a alimentação da sua criança influencia as suas relações familiares?	1 Não influencia nada	2	3	4	5	6	7 De forma muito negativa

ANEXO 3 - American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System (ASHA-NOMS)

ASHA-NOMS scale	
LEVEL 1:	Individual is not able to swallow anything safely by mouth. All nutrition and hydration is received through non-oral means (e.g., nasogastric tube, PEG).
LEVEL 2:	Individual is not able to swallow safely by mouth for nutrition and hydration, but may take some consistency with consistent maximal cues in therapy only. Alternative method of feeding is required.
LEVEL 3:	Alternative method of feeding required as individual takes less than 50% of nutrition and hydration by mouth, and/or swallowing is safe with consistent use of moderate cues to use compensatory strategies and/or requires maximum diet restriction.
LEVEL 4:	Swallowing is safe, but usually requires moderate cues to use compensatory strategies, and/or the individual has moderate diet restrictions and/or still requires tube feeding and/or oral supplements.
LEVEL 5:	Swallowing is safe with minimal diet restriction and/or occasionally requires minimal cueing to use compensatory strategies. The individual may occasionally self-cue. All nutrition and hydration needs are met by mouth at mealtime.
LEVEL 6:	Swallowing is safe, and the individual eats and drinks independently and may rarely require minimal cueing. The individual usually self-cues when difficulty occurs. May need to avoid specific food items (e.g., popcorn and nuts), or require additional time (due to dysphagia).
LEVEL 7:	The individual's ability to eat independently is not limited by swallow function. Swallowing would be safe and efficient for all consistencies. Compensatory strategies are effectively used when needed.